PRECONSULT / TEST CASE MANUAL

两套病例，逐步照填

患者端、附件提取、AI Wizard 与医生分享的手动验收材料

所有人物、图片、数值和医疗检查表均为虚构测试数据，不是真实医疗记录。 这是测试材料包；未替用户注册、修改现有患者档案、上传资料或向医生分享。

先完成这 6 步

01 打开 http://127.0.0.1:8000/#/patient，语言选择“简体中文”。本说明对应2026-10-21本地代码；应用默认语言仍为英语。

02 准备两个你控制且能收验证码的独立测试邮箱，分别用于TC01与TC02；与医生邮箱也必须不同。邮箱填你的实际测试邮箱，验证码填收到的验证码；没有固定测试密码。

03 登录时选择“患者”。若页面要求姓名，分别填 Alex Lin (TEST) 或 Maya Chen (TEST)；已有测试账号可在“我的账号”修改名称。不要把两例混在同一个患者档案里。

04 在“我的账号”或新建页的“添加档案”中，依照本例7步保存健康背景。新建就诊时开启“本次就诊使用已保存的信息”。

05 点“新建就诊准备”，选择本例指定症状卡片。高级选项保留 gpt-6-astra；勾选AI处理同意，再点“开始吧”。如显示就诊标题，可使用本例TC编号加标题。

06 每个问题先点指定选项，再把“填写内容”复制到文字框；复制内容不包含系统的 Selected options 等内部格式。每步点“继续”，最后点“检查回答”。

语音交互专项检查

01 在TC01第1题用语音读出给定文字。先授予浏览器麦克风权限，然后录音。

02 点方形停止后应开始转写，结果直接填入本题原有的可编辑输入框；不出现额外的转写确认步骤，也无需先点发送箭头。

03 在原输入框中检查日期、“双侧”和“右膝”等关键字，并按需修改；完成后直接点“继续”或当前页面的提交按钮。停止录音只回填文字，不应自动提交或跳到下一题。

阅读路线

TC01 双膝疼痛：第 2-6 页；TC02 高血压复查：第 7-10 页；附件核对与通用验收：第 11-12 页。每例独立患者账号，按顺序完成档案、症状问题、附件与追问。

TC01 / WF-01 · 腿痛

双膝疼痛：部位多选与既往反应

38岁男性，长距离步行后双侧膝盖前方酸痛，右膝有一小块瘀痕。用于测试多选、语音、未知Rh、药物历史和图片/PDF的一致性。

患者姓名：Alex Lin (TEST)。先保存以下 7 项健康背景。

步骤 / 基本信息	填写内容
01 您的出生日期是？	1988-04-12
02 出生时记录的生理性别是什么？	男性
03 您知道自己的血型吗？	ABO选 O；Rh选“我不知道”（保存为 O，不是 O+ 或 O−）。
04 有哪些需要记住的病史？	无已确诊的长期疾病。
05 您做过手术吗？	无手术史。
06 有哪些相关家族健康史？	父亲有高血压。
07 怎样让您的就诊更方便？	偏好简体中文；无额外沟通或行动协助需求。

本例上传文件

case01/knee-photo.png

上传本图。照片日期2026-10-19；右膝瘀痕在画面左边。

case01/medical-exam.pdf

上传本报告。检查日期2026-10-20；包含生命体征、双膝查体、药物与过敏自述。

图片 OCR 替代附件

case01/medical-exam-page-1.png
检查表 PNG（测试图片OCR时替代同一份PDF）

TC01 / 健康信息 WIZARD

第 1-4 题

有选项时先点选，再填写正文；每题完成后点“继续”。

第 1 题 请简单说说您的腿哪里不舒服、是什么感觉。

直接填写 / 语音输入

2026年10月14日长距离步行后，双侧膝盖前方开始酸痛，走路和上下楼梯时比较明显。10月19日注意到右膝前方有一小块淡淡的瘀痕，仍然可以走路。

操作提示：可用语音读这一段：点麦克风 → 说话 → 点方形停止 → 转写自动填入本题原有输入框 → 在输入框中核对、修改 → 继续。

第 2 题 您的腿部哪里疼痛？

先选：右侧膝盖 · 正面；左侧膝盖 · 正面

两边都是膝盖前方，右侧比左侧明显；瘀痕只在右膝。

操作提示：切到“正面”，分别点膝盖行的“右”和“左”；应同时保留两处高亮。左右以患者身体为准，照片中的右膝位于画面左侧。

第 3 题 请用自己的话描述疼痛的感觉。

先选：酸痛；僵硬

以酸痛和轻微僵硬为主。

第 4 题 这种情况多久发生一次？

先选：每天多次

每天走动时会出现几次，不是一直疼。

身体部位可多选。右膝和左膝都选择“正面”，不是以照片观看者的左右来判断。

TC01 / 健康信息 WIZARD

第 5-8 题

保留日常影响与本次就诊目标；不必重复已存的基本病史。

第 5 题 感觉疼痛时，您通常在做什么？

先选：步行；上下楼梯

长距离步行或上下楼梯时明显。

第 6 题 您注意到什么会使疼痛发生变化？

先选：随活动变化；随休息变化

走得久或上下楼梯时更明显；坐下休息大约20分钟后减轻。

第 7 题 这对您的日常活动有什么影响？

先选：运动或活动

暂停了平时的跑步；仍能走路和完成日常事务，坐着工作与睡眠没有明显受影响。

第 8 题 您希望这次就诊达到什么目标？

先选：了解我的症状；讨论下一步安排

希望了解双膝不适和右膝瘀痕的情况，讨论接下来的检查或活动安排。

TC01 / 健康信息 WIZARD

第 9-11 题与核对

药物与反应要保留时间、剂量及不确定性。

第 9 题 您目前使用哪些药物、吸入剂或补充剂？

直接填写 / 语音输入

目前每天服用维生素C 1片，每片剂量不清楚。2026年10月19日曾服用对乙酰氨基酚500 mg一次；不是每天服用。没有使用其他药物或吸入剂。

第 10 题 您希望记录哪些过敏或既往药物反应？

直接填写 / 语音输入

2015年服用阿莫西林后出现皮疹，这是我的回忆，尚未确认是否过敏，没有做过正式过敏检测。

第 11 题 还有什么希望医生了解的？

直接填写 / 语音输入

我担心这会影响月底的徒步计划。想问医生目前是否需要调整活动，以及有哪些需要进一步了解的情况。

TC01 关键预期结果

01 身体图同时保留“右膝前方”和“左膝前方”；仅右膝有瘀痕，不得误写成左侧或双侧瘀痕。

02 档案中血型是 O，Rh未知；不得补成 O+。已保存病史应带入本次，不能要求重复输入。

03 维生素C为当前补充剂且剂量未知；对乙酰氨基酚500 mg是10月19日的一次历史用药，不应变为每日药物。

04 阿莫西林皮疹应保留“患者自述、未确认”；不得写成已经确诊的过敏或完全没有过敏。

05 检查表读数应保留：122/78 mmHg、72次/分、36.7°C、178 cm、74 kg；右膝活动范围0–125°，左膝0–130°。

06 没有影像或化验，不能生成“X光/MRI正常”；照片仅用于测试外观描述，不能作为确诊依据。

TC01 / AI 分析与追问

5 组事实参考答案

这些是答案库，不是固定会出现的 5 道题。根据实际追问选择对应事实。

每题一个 Wizard 步骤。建议选项吻合才点选；否则自定义。已知信息不要重复捏造，未知值用“我不知道”或跳过。

01 开始时间 / 发展变化

2026年10月14日开始。到10月21日总体差不多，没有持续加重。

02 持续性 / 频率 / 程度

时有时无，每天活动时出现几次。上下楼梯时大约4/10，休息时大约1/10；不是持续不间断的疼痛。

03 已经尝试的方法 / 效果

减少长距离步行和跑步，休息后会减轻。2026年10月19日只服过一次对乙酰氨基酚500 mg，效果不确定。

04 之前就诊 / 检查 / 医生说明

2026年10月20日做过膝部体格检查，记录已上传。未建立明确诊断，没有X光、MRI或化验结果。医疗人员姓名未在本测试资料中提供。

05 外伤、瘀痕或药物/反应的细节

没有记得明显跌倒或扭伤；10月19日发现右膝淡瘀痕，具体形成原因不清楚。维生素C每片剂量不清楚；阿莫西林后的皮疹是2015年的自述，未正式确认。

第二次就诊：记忆与历史回答检查

同一测试患者新建第二次“腿痛”就诊。确认7项档案复用；药物与过敏输入下方显示上次回答及日期。点击“填入本次回答”后，将药物改为“目前每天维生素C 1片，剂量未知；上次提到的对乙酰氨基酚是2026-10-19的一次用药，此后没有再服用。”核对旧记录不被改写。

TC02 / WF-24 · 已确诊高血压复查

高血压复诊：连续读数与化验附件

55岁女性，已有高血压与血脂异常病史，带7天家庭血压记录和化验报告复查，无新症状。用于测试连续数值、单位、用药及附件提取。

患者姓名：Maya Chen (TEST)。使用与 TC01 不同的测试账号。

步骤 / 基本信息	填写内容
01 您的出生日期是？	1971-09-08
02 出生时记录的生理性别是什么？	女性
03 您知道自己的血型吗？	ABO选 AB；Rh选“阳性（+）”（保存为 AB+）。
04 有哪些需要记住的病史？	2021年被告知有高血压；2024年被告知有血脂异常。
05 您做过手术吗？	1999年做过阑尾切除手术。
06 有哪些相关家族健康史？	父亲有高血压，母亲有糖尿病。
07 怎样让您的就诊更方便？	偏好简体中文，希望获得清晰的书面用药清单。

本例上传文件

case02/bp-monitor-photo.png

上传本图。显示2026-10-20 19:30：141/88 mmHg，脉搏72，对应日志最后一条。

case02/checkup-and-bp-log.pdf

上传完整2页PDF。第1页为9项空腹化验；第2页为14次家庭血压和脉搏。

图片 OCR 替代附件

case02/checkup-and-bp-log-page-1.png
报告第1页 PNG（测试图片OCR时替代PDF）

case02/checkup-and-bp-log-page-2.png
报告第2页 PNG（测试图片OCR时替代PDF）

TC02 / 健康信息 WIZARD

第 1-4 题与读数

家庭血压为历史记录；不得把旧日期替换成今天。

第 1 题 这次就诊，您想具体讨论这方面的什么问题？

直接填写 / 语音输入

这次是预约的高血压复查，没有新出现的不适。我想一起看看最近7天的家庭血压记录、10月18日的化验结果和目前的用药情况。

第 2 题 医生曾如何向您解释血压情况？

直接填写 / 语音输入

2021年医生告知我有高血压，之后一直定期复查。2024年又被告知血脂异常。具体的个人血压目标我记不清楚，希望这次确认。

第 3 题 上次相关就诊是什么时候？

直接填写 / 语音输入

2026年10月8日，诊室血压146/90 mmHg，脉搏74次/分。

第 4 题 您想纳入哪些已有血压读数？

填写：先复制测量说明，再复制全部 14 行及最后的统计说明。

家庭上臂式电子血压计，左上臂，坐位休息5分钟后测量。每天07:30和19:30各记录一次，血压单位mmHg，脉搏单位次/分。

日期与时间	血压 / mmHg	脉搏 / 次每分
2026-10-14 07:30	138/86	70
2026-10-14 19:30	142/88	72
2026-10-15 07:30	140/87	69
2026-10-15 19:30	144/89	73
2026-10-16 07:30	141/88	71
2026-10-16 19:30	145/90	75
2026-10-17 07:30	136/84	68
2026-10-17 19:30	139/86	70
2026-10-18 07:30	143/89	72
2026-10-18 19:30	140/87	71
2026-10-19 07:30	137/85	69
2026-10-19 19:30	138/86	70
2026-10-20 07:30	139/87	70
2026-10-20 19:30	141/88	72

14次读数的算术平均为140.2/87.1 mmHg，平均脉搏70.9次/分。最后一次为2026-10-20 19:30的141/88，脉搏72。照片对应最后一条记录。

操作提示：直接复制完整14条读数；这一步是文字输入，不需要逐行新建表格。10月20日是附件整理日期，最近一次诊室复查仍是10月8日。

TC02 / 健康信息 WIZARD

第 5-9 题

检查单位、用药时间与漏服次数；本次为预约复查，没有新症状。

第 5 题 您想在这次复查中提及哪些变化？

先选：日常作息；居家记录

最近整理了7天的家庭血压记录。10月16日早晨外出时漏服了一次氨氯地平，希望讨论怎样更容易记住服药；没有新症状。

第 6 题 您希望这次就诊达到什么目标？

先选：复查已有健康问题；讨论检查结果；讨论用药

希望复查已有高血压，讨论家庭血压及化验结果，并核对现在的用药和漏服情况。

第 7 题 您目前使用哪些药物、吸入剂或补充剂？

直接填写 / 语音输入

氨氯地平（amlodipine）5 mg，每天07:30服一次，仅2026年10月16日漏服一次。阿托伐他汀（atorvastatin）10 mg，每晚服一次。没有使用其他药物、吸入剂或补充剂。

第 8 题 您希望记录哪些过敏或既往药物反应？

直接填写 / 语音输入

据我所知，没有药物或食物过敏，也没有需要记录的既往药物反应。

第 9 题 还有什么希望医生了解的？

直接填写 / 语音输入

希望医生帮我确认个人血压目标，解释这次化验结果，并讨论如何避免忘记服药。没有其他新症状需要补充。

TC02 / AI 分析与追问

5 组事实参考答案

AI 可以少问或不问；只按病例已提供的信息回答。

01 家庭读数来源 / 时间 / 单位

家庭上臂式电子血压计，左上臂；坐位休息5分钟后测量。2026-10-14至2026-10-20，每天07:30和19:30各一条。血压单位mmHg，脉搏单位次/分。每次只记录了一条，未提供重复测量值。

02 用药体验 / 漏服 / 副作用

氨氯地平5 mg每天07:30，只有10月16日漏服一次；阿托伐他汀10 mg每晚。目前未注意到明显药物不适，希望讨论帮助记住服药的方法。

03 已做检查 / 化验日期

2026年10月18日08:10空腹采血；具体9项数值和单位见已上传PDF第1页。10月20日只是测试附件整理日期，不是另一次诊室复查。

04 以前就诊 / 医生说明 / 目标

最近一次诊室复查为2026年10月8日，146/90 mmHg，脉搏74。2021年被告知有高血压。个人目标值和医疗人员姓名未在本测试资料中提供，我不确定。

05 新症状 / 生活影响 / 其他担忧

本次是预约复查，没有新症状，日常活动没有新的受限。主要希望理解家庭记录和检查结果，并讨论漏服药的情况。

第二次就诊：旧读数不可变成新数据

同一测试患者再次新建“已确诊高血压复查”。档案应自动带入；上次药物和无已知过敏回答只作为可点击候选。不要把10月14–20日的旧血压当成今天新测值；若再次使用，应明确写“历史记录，日期不变”。

如果追问个人血压目标值或医疗人员姓名，本材料没有提供，选择“我不知道”；不要自行推定。

附件与结果核对

数值、来源与交互

重点核对多个附件的日期、左右侧和单位；不要只看摘要是否流畅。

上传附件：共同操作

01 在“添加文件或返回某个问题”展开区，或右侧“辅助文件”区域，上传本例列出的1张照片与1份PDF。建议在最终AI分析前上传。

02 只选择本例文件，不要把另一病例的资料混入。PDF页面PNG是OCR替代测试用：同一次正常测试无需将PDF和它的页面PNG重复上传。

03 若提供“提取详情”，点击后核对日期、患者、左右侧、单位，再确认纳入。识别不清的值应回到原报告核对，不猜测。

04 支持PDF、PNG、JPG、WebP，单个文件上限10 MB；本包的每个上传文件均小于上限。

AI Wizard：共同交互检查

01 点击开始AI分析与追问后，每题应独立占一个Wizard步骤，显示进度；通常一次最多5题，完成后统一检查和提交。

02 AI会根据已填写及附件选择问题，下面每例的5组是事实答案库，不保证出现5题或固定顺序；已有答案被识别后可以少问或不问。

03 A/B/C选项与病例事实吻合时才选择，再按需补充；不吻合则自定义填写。没有资料的剂量、日期或医疗人员姓名，选“我不知道”或跳过，不编造。

04 完成一题后测试“返回”再前进，答案应保留；完成部分题目后刷新，应恢复已存草稿。全部答完点检查回答，逐项确认后再统一提交。正常情况下不应无故启动第二轮。

TC02 关键预期结果

01 保留“预约复诊、没有新症状”；不应把本次写成新发症状问诊，也不应强制新增疼痛程度。

02 档案血型是 AB+；高血压2021年、血脂异常2024年及阑尾切除1999年的信息保持一致。

03 14次家庭读数不能与诊室146/90混在一起计算。若显示均值，应为140.2/87.1 mmHg、脉搏70.9次/分；最新读数141/88、72与照片吻合。

04 必须保留采血日期10月18日与诊室复查10月8日的区别，不能把附件整理日期10月20日当作采血或诊室复查日期。

05 氨氯地平5 mg每天早晨、阿托伐他汀10 mg每晚；仅10月16日漏服一次，不能扩写成长期不规律服药。

06 PDF两页均可被处理。化验值及单位应与原文一致；不得把肌酐74 μmol/L写成74 mg/dL或自行添加报告未给出的参考范围。

最终人工验收

审核、分享与撤回

分享仅由你在核对后手动执行；生成本材料没有改变任何患者或医生记录。

01 审核页逐项核对：姓名、出生日期、血型、部位/症状、时间、药物与过敏、附件、AI分析。具体措辞或分析结论不必与示例完全一致，但不得捏造病例事实。

02 若出现旧版“相关病史”“最担心的事”“想问医生的问题”三个展开项：病史应来自档案；担忧和咨询问题已合并填在“还有什么希望医生了解的”，不必再重复输入。

03 仅在你要实际测试分享时，填写已注册的医生邮箱 jtomtan@qq.com（tomtan，末尾没有额外的g），确认患者邮箱与它不同。

04 检查内容后勾选批准分享，点击“批准并分享”。这是会改变本地分享状态的手动步骤，本材料包未代为执行。

05 用另一个浏览器配置或无痕窗口打开 http://127.0.0.1:8000/#/doctor，选医生并用该邮箱收到的验证码登录。应该看到获授权的对应病例、审核后的摘要和附件；不应串到另一个患者。

06 可再从患者端撤回分享，刷新医生页验证访问已撤销。未注册邮箱的负向测试：应显示医生需先注册的提示并保留草稿，不应显示成功。

材料范围与验证边界

01 每例7个档案字段；TC01固定11题，TC02固定9题；条件项或AI问题可能随证据出现。

02 测试材料中的每个关键数值、时间、左右侧都有明确来源；病例间不混用。

03 材料包生成及验证不依赖调用AI服务，未验证实际模型输出；实际跑测时记录差异，而不是声称已经通过。

随包数据与来源

testcases.json：所有逐题答案、选项、验收要点的结构化版本。
report-data.json：检查表与 14 次血压的结构化原始值。
field-map.json：当前工作流字段与控件映射。
source/image-prompts.json：两张测试图片的生成提示。

测试执行结果请另行记录。本文提供的是可复现的输入和预期，不表示实际模型、上传服务或医生分享流程已跑通。